SDD 223 Sujet n°1

Spécialité : Hématologie

Date : 30/09/2023
Auteur : Dr Pierre-Edouard Debureaux
Relecteur(s) : Pr Perrot et Dr Talbot ; ELAYLI Robin

Domaine d'apprentissage principal	- Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	- Interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	212 – Analyse de l'hémogramme 213 - Anémie
Situation(s) de départ en lien avec la station	223 – Analyse de l'hémogramme
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Consultation en médecine générale

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste. Vous recevez Madame P. G. 24 ans, que vous avez eu il y a une semaine pour la première fois (changement de médecin traitant car départ à la retraite) pour une asthénie progressive depuis plusieurs mois associée à une pâleur cutanée. Elle vient vous voir avec le bilan que vous lui avez prescrit lors de la dernière consultation :

- Leucocytes 5,1 G/L dont : PNN 3 G/L, Monocytes 0,5 G/L, PN basophiles 0,01 G/L, PN éosinophile 0,1 G/L, Lymphocytes 1,5 G/L.
- Hb 6 g/dL, VGM 70 μm^3
- Plaquette 470 G/L.

Ferritine 10 ng/mL (norme > 50 ng/mL). TSH 2 mUI/L, Bilan hépatique normal et créatinine 30 µmol/L, CRP 2 mg/L

Consignes :

- Réaliser l'interrogatoire et l'examen clinique centré de la patiente (expliquez à haute voix ce que vous cherchez) pour sa carence martiale

Ne pas faire :
Il n'est pas nécessaire de détailler le traitement.

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Interrogatoire			
1.	Recherche des antécédents familiaux ET personnels de (0,5 pt par élément, pas de point si ne demande que les antécédents personnels ou que familiaux) : - Cancer (digestif, gynécologique…) - Trouble de l'hémostase - Malabsorptions	1,5 pt	☐
2.	Recherche d'ATCD personnel gynécologique (0,5 pt par élément recherché) : ● Fibrome ● Fausse couche ● Grossesse récente avec hémorragie OU grossesse rapprochée	1,5 pt	☐
3.	Recherche NFS précédente, antériorité	1 pt	☐
4.	Interroge sur les traitements du patient (0,5 pt par élément) - Recherche de prise de médicament - Recherche la prise d'anticoagulant - Recherche la prise d'anti-agrégants - Recherche la prise d'AINS	2 pt	☐
5.	Recherche de saignement extériorisé à l'interrogatoire (0,5 pt par éléments) : - Hémorragie digestive - Urinaire - Épistaxis à répétition	1,5 pt	☐
6.	Recherche TOUS les signes de mauvaise tolérance de l'anémie : dyspnée, lipothymies, confusion, douleurs thoraciques	1 pt	☐
Bonus	Recherche de trouble alimentaire type PICA (cailloux, glaçon), consommation de thé	+1 pt	☐

<table>
<tr><th colspan="4">Examen clinique</th></tr>
<tr><td>7.</td><td>Prise de constantes (0,5 pt par élément) :
- Prise de la fréquence cardiaque
- Prise de la Tension</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Evaluation des menstruations avec :
- Échelle de Higham OU
- Demande abondance en terme de durée de règle ET de la fréquence de changement de protection</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Rechercher syndrome anémique (0,5 pt par élément) :
- Une pâleur conjonctivale
- Une paleur cutanée</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Recherche des hémorragies à l’examen clinique (0,5 pt par élément) :
● Cutanée : recherche de purpura et hémorragie active cutanée en soulevant le t-shirt
● Buccale : examen buccal
● Nasale : recherche de télangiectasie dans la zone entre le nez et la bouche/entrée des narines</td><td>1,5 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Palpation abdominale (à la recherche d’une étiologie digestive de la carence martiale)</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><th colspan="4">Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair
<table>
<tr><th>Performance Insuffisante

0 point</th><th>Performance Limite

0,25 point</th><th>Performance Satisfaisante

0,5 point</th><th>Performance Très Satisfaisante

0,75 point</th><th>Performance Remarquable

1 point</th></tr>
<tr><td>Interrompt le patient /pair de façon inappropriée

Ignore les réponses du patient/collègue</td><td>Se montre impatient</td><td>Est attentif aux réponses du patient/pair</td><td>Est attentif aux réponses du patient/pair

Adopte la technique de reformulation si l’information est imprécise ou éloignée des objectifs.</td><td>Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.</td></tr>
</table></td><td>1 pt</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>2.</td><td>

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

</td><td>1 pt</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

</td><td>1 pt</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>

10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

</td><td>1 pt</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL (max 20 items) sur 20 points</td><td>…/20 points</td></tr>
</table>

<u>Éléments de rétroaction :</u>

Il faut toujours recherche une cause gynécologique chez une femme en âge de procréer puis les causes digestives (attention la recherche de sang dans les selles n'est pas suffisante).

Pour réviser l'interrogatoire pour les menstruations et son abondance, je vous conseille d'aller lire l'échelle d'Higham qui permet de mieux se repérer sur l'abondance des menstruations.

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Bilan d'une anémie par carence en fer

Plan de la station ECOS :

Assis sur une chaise dans un bureau de consultation

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Bonjour Docteur, Je suis toujours fatigué, est ce que la prise de sang explique ma fatigue ? Tendre la prise de sang

Identité du patient :

Madame P. G., 24 ans, 70 kg, 1m60

Mode de vie :

Vit en couple, G1P0 (avortement il y a 2 ans), jamais eu de frottis cervico-utérien. Pas de vaccin contre l'HPV Régime végétarien Pas d'alcool, pas de tabac Pas d'allergie

Comportement global :

Lenteur à la réponse (légèrement ralenti sur le syndrome anémique)

Antécédents personnels :

0

Antécédents familiaux :

Cancer de la prostate chez le grand-père paternel à 80 ans

Médicaments :

Pilule oestroprogestative depuis son avortement : Leelo

Symptômes positifs :

Voici les signes à communiquer et les conditions dans lesquels les communiquer :
- Si regarde les ongles, dire "la tu vois des ongles cassant"
- Si fait une auscultation cardiaque au niveau du foyer aortique (2ème espace intercostal droit, sur le côté droit haut du sternum) : lui dire qu'iel entend un souffle systolique
- Si examen cutanée : la peau est pâle
- Si examen ophtalmologique (des yeux) : la paupière intérieure inférieure est blanche avec absence de vaisseaux sanguins.
- Si question sur l'abondance des règles (nombre de protections ou modification ?) : Présence de règles plus abondantes (changement toutes les 30 minutes de protection pendant 7 jours) présent depuis plusieurs mois (qu'elle a essayé de calmer en commençant un régime végan) avec des saignements présents également entre les périodes de menstruations.
- Si demande si saignement dans les urines, dans les selles ou émis par la bouche : "Non je n'ai pas vu de sang dans mes urines/selles/crachat"
- Si demande si vomissement : "Non je n'ai pas eu de vomissement"

Le reste de l'examen clinique est normal
- Si dit vouloir prendre la tension : Lui dire que la tension est à 100/60
- Si écoute le rythme de votre coeur, dire que la fréquence cardiaque est à 115

Constantes :

FC 115, TA 100/60, SatO2 98%, T 36,5°C

Donnée complémentaire :

Bilan sanguin fourni dans la consigne

Questions de relance :

Non applicable

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Assis sur une chaise en face du/de la candidat.e, de part et d'autre d'un bureau

Matériel nécessaire à la station :

- Stylo pour le/la candidat.e
- Une feuille blanche
- Un Stéthoscope